

Nombre del Prestador :	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
Seguro	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Nombre del Paciente	PEÑAFIEL DIAZ LUIS RODRIGO
Cedula de identidad	0100160480
Historia Clínica	60480
Fecha de Ingreso	2025-10-22
Fecha de Egreso	2025-10-23
Procedimiento	ECOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA, CPRE
Diagnostico	(K85) PANCREATITIS AGUDA
PLANILLA DE CARGOS DEL PROVEEDOR(CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA)	

HONORARIOS MEDICOS								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-22	43259	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON ECOENDOSCOPIA, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SI ES APROPIADO.	1	\$136,26	\$136,26	\$0,00	\$0,0000	\$136,26
2025-10-22	43259	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON ECOENDOSCOPIA, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SI ES APROPIADO.	1	\$60,60	\$60,60	\$0,00	\$0,0000	\$60,60
2025-10-22	43259	TIEMPO DE ANESTESIA	4	\$12,12	\$48,48	\$0,00	\$0,0000	\$48,48
2025-10-23	43273	CANULACION ENDOSCOPICA DE LA PAPILA, CON VISUALIZACION DIRECTA DEL CONDUCTO BILIAR O CONDUCTO PANCREATICO (LISTAR POR SEPARADO AL PROCEDIMIENTO PRIMARIO)	1	\$32,06	\$32,06	\$0,00	\$0,0000	\$32,06
2025-10-23	43264	COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (ERCP), CON REMOCION ENDOSCOPICA RETROGRADA DE CALCULOS DEL CONDUCTO BILIAR Y/O PANCREATICO.	1	\$200,38	\$200,38	\$0,00	\$0,0000	\$200,38
2025-10-23	43264	COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (ERCP), CON REMOCION ENDOSCOPICA RETROGRADA DE CALCULOS DEL CONDUCTO BILIAR Y/O PANCREATICO.	1	\$60,60	\$60,60	\$0,00	\$0,0000	\$60,60
2025-10-23	43264	TIEMPO DE ANESTESIA	4	\$12,12	\$48,48	\$0,00	\$0,0000	\$48,48
2025-10-23	43268	COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (ERCP), CON INSERCIÓN ENDOSCOPICA RETROGRADA DE TUBO O STENT EN EL CONDUCTO BILIAR O PANCREATICO.	1	\$84,16	\$84,16	\$0,00	\$0,0000	\$84,16
2025-10-23	43262	COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (ERCP), PARA ESFINTERECTOMIA / PAPILOTOMIA.	1	\$84,16	\$84,16	\$0,00	\$0,0000	\$84,16
Total			HONORARIOS MEDICOS					\$755,18

MEDICINAS - VALOR AL ORIGEN								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-22		SEVOFLURANO INHALACION. SOLUCION PARA INHALACION 1 MG/ML. PRESENT. 250ML	49	\$0,86	\$42,14	\$0,00	\$0,0000	\$42,14
2025-10-22		LACTATO RINGER LIQUIDO PARENTERAL PARA INFUSION ND 1000 ML. PRESENT. 1000 ML (1000ML)	1	\$1,93	\$1,93	\$0,00	\$0,0000	\$1,93
2025-10-22		PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL EMULSION INYECTABLE 10 MG / ML AMPOLLA/FRASCO. PRESENT. 200MG/20 ML	30	\$1,04	\$31,20	\$0,00	\$0,0000	\$31,20
2025-10-22		ROCURONIO, BROMURO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML PRESENT 50MG/5ML	1	\$10,29	\$10,29	\$0,00	\$0,0000	\$10,29
2025-10-22		LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 2% PRESENT. 10 ML	1	\$1,32	\$1,32	\$0,00	\$0,0000	\$1,32
2025-10-22		BUTIL ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA) - LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 20MG / ML PRESENT.20MG	1	\$1,27	\$1,27	\$0,00	\$0,0000	\$1,27
2025-10-22		ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 8MG PRESENT.8MG/4ML	1	\$3,02	\$3,02	\$0,00	\$0,0000	\$3,02
2025-10-22		FENTANILO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,05MG/10ML	1	\$0,25	\$0,25	\$0,00	\$0,0000	\$0,25
2025-10-22		DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 4 MG / ML PRESNT. 4MG/ML	2	\$0,34	\$0,68	\$0,00	\$0,0000	\$0,68
2025-10-22		CEFTRIAXONA SOLIDO PARENTERAL POLVO PARA INYECCION 1G PRESENT. 1GR	1	\$7,63	\$7,63	\$0,00	\$0,0000	\$7,63
2025-10-22		ATROPINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 1 MG - ML PRESNT. 1ML	1	\$0,45	\$0,45	\$0,00	\$0,0000	\$0,45
2025-10-22		NEOSTIGMINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,5 MG / ML PRESENT 0,5 MG /1ML	4	\$0,64	\$2,56	\$0,00	\$0,0000	\$2,56
2025-10-22		KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 30 MG / ML PRESENT. 30 MG	2	\$2,15	\$4,30	\$0,00	\$0,0000	\$4,30
2025-10-22		OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG	1	\$5,46	\$5,46	\$0,00	\$0,0000	\$5,46
2025-10-23		SEVOFLURANO INHALACION. SOLUCION PARA INHALACION 1 MG/ML. PRESENT. 250ML	49	\$0,86	\$42,14	\$0,00	\$0,0000	\$42,14
2025-10-23		LACTATO RINGER LIQUIDO PARENTERAL PARA INFUSION ND 1000 ML. PRESENT. 1000 ML (1000ML)	1	\$1,93	\$1,93	\$0,00	\$0,0000	\$1,93
2025-10-23		PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL EMULSION INYECTABLE 10 MG / ML AMPOLLA/FRASCO. PRESENT. 200MG/20 ML	30	\$1,04	\$31,20	\$0,00	\$0,0000	\$31,20
2025-10-23		ROCURONIO, BROMURO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML PRESENT 50MG/5ML	1	\$10,29	\$10,29	\$0,00	\$0,0000	\$10,29
2025-10-23		LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 2% PRESENT. 10 ML	1	\$1,32	\$1,32	\$0,00	\$0,0000	\$1,32
2025-10-23		BUTIL ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA) - LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 20MG / ML PRESENT.20MG	1	\$1,27	\$1,27	\$0,00	\$0,0000	\$1,27
2025-10-23		ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 8MG PRESENT.8MG/4ML	1	\$3,02	\$3,02	\$0,00	\$0,0000	\$3,02
2025-10-23		FENTANILO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,05MG/10ML	1	\$0,25	\$0,25	\$0,00	\$0,0000	\$0,25
2025-10-23		DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 4 MG / ML PRESNT. 4MG/ML	2	\$0,34	\$0,68	\$0,00	\$0,0000	\$0,68
2025-10-23		CEFTRIAXONA SOLIDO PARENTERAL POLVO PARA INYECCION 1G PRESENT. 1GR	1	\$7,63	\$7,63	\$0,00	\$0,0000	\$7,63
2025-10-23		ATROPINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 1 MG - ML PRESNT. 1ML	1	\$0,45	\$0,45	\$0,00	\$0,0000	\$0,45
2025-10-23		NEOSTIGMINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,5 MG / ML PRESENT 0,5 MG /1ML	4	\$0,64	\$2,56	\$0,00	\$0,0000	\$2,56
2025-10-23		KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 30 MG / ML PRESENT. 30 MG	2	\$2,15	\$4,30	\$0,00	\$0,0000	\$4,30
2025-10-23		OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG	1	\$5,46	\$5,46	\$0,00	\$0,0000	\$5,46
Total			MEDICINAS - VALOR AL ORIGEN					\$225,00

INSUMOS - VALOR AL ORIGEN								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-22		OXIGENO LITROS MINUTO	300	\$0,01	\$3,00	\$0,00	\$0,0000	\$3,00
2025-10-22		CAP REVEAL 12.4 MM DESCARTABLE	1	\$20,00	\$22,00	\$2,00	\$3,3000	\$25,30
2025-10-22		KIT-CIRCUITO DE ANESTESIA DESCARTABLE	1	\$13,00	\$14,30	\$1,30	\$2,1450	\$16,45
2025-10-22		ELECTRODOS 3M DESCARTABLE	3	\$0,28	\$0,93	\$0,08	\$0,1395	\$1,07
2025-10-22		BOLSA DE SUCCION DESCARTABLE	1	\$4,50	\$4,95	\$0,45	\$0,7425	\$5,69
2025-10-22		EQUIPO VENOCISIS DESCARTABLE	1	\$0,29	\$0,32	\$0,03	\$0,0480	\$0,37

INSUMOS - VALOR AL ORIGEN								
2025-10-22		CATETER N°20 DESCARTABLE	1	\$0,75	\$0,83	\$0,08	\$0,1245	\$0,95
2025-10-22		MANGUERA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$2,75	\$3,03	\$0,28	\$0,4545	\$3,48
2025-10-22		JERINGAS DE 10 ML DESCARTABLE	2	\$0,11	\$0,24	\$0,02	\$0,0360	\$0,28
2025-10-22		JERINGAS DE 20 ML DESCARTABLE	2	\$0,18	\$0,40	\$0,04	\$0,0600	\$0,46
2025-10-22		Bite Block Adulto DESCARTABLE	1	\$8,00	\$8,80	\$0,80	\$1,3200	\$10,12
2025-10-22		SONDA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$0,90	\$0,99	\$0,09	\$0,1485	\$1,14
2025-10-22		BATA PACIENTE DESCARTABLE	1	\$1,20	\$1,32	\$0,12	\$0,1980	\$1,52
2025-10-22		BATA QUIRURGICA M DESCARTABLE	3	\$1,30	\$4,29	\$0,39	\$0,6435	\$4,93
2025-10-22		GORRO QUIRURGICOS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-22		MASCARILLA QUIRURGICAS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-22		ZAPATONES DESCARTABLE	8	\$0,20	\$1,76	\$0,16	\$0,2640	\$2,02
2025-10-22		GUANTES MANEJO M-S DESCARTABLE	6	\$0,07	\$0,48	\$0,04	\$0,0720	\$0,55
2025-10-22		TEGADERM APOSITO DE FIJACION DESCARTABLE	1	\$0,70	\$0,77	\$0,07	\$0,1155	\$0,89
2025-10-22		LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENCION DESCARTABLE	1	\$0,30	\$0,33	\$0,03	\$0,0495	\$0,38
2025-10-22		TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0MM DESCARTABLE	1	\$1,85	\$2,04	\$0,19	\$0,3060	\$2,35
2025-10-23		OXIGENO LITROS MINUTO	300	\$0,01	\$3,00	\$0,00	\$0,0000	\$3,00
2025-10-23		Empujador 10 fr, long catéter 2200 mm, canal de trabajo 2.8 Estéril. Descartable	1	\$180,00	\$198,00	\$18,00	\$29,7000	\$227,70
2025-10-23		Stent Biliar Plástico 10fr x 12cm Amsterdam Type Estéril. Descartable	1	\$154,55	\$170,01	\$15,46	\$25,5015	\$195,51
2025-10-23		PAMIRAY 300 AMP X100ML	1	\$47,63	\$52,39	\$4,76	\$7,8585	\$60,25
2025-10-23		CAP REVEAL 12.4 MM DESCARTABLE	1	\$20,00	\$22,00	\$2,00	\$3,3000	\$25,30
2025-10-23		Balón de Extracción de cálculos Biliares, triple lumen, 12-15-18, inyección distal, Diam catéter 7fr long 200cm, canal de trabajo 2.8 Estéril. Descartable	1	\$530,00	\$583,00	\$53,00	\$87,4500	\$670,45
2025-10-23		Esfinterotomo de Canulación, triple lumen, punta cónica 5mm, alambre de corte 20mm con aislante, long 200cm Estéril. Descartable	1	\$665,00	\$731,50	\$66,50	\$109,7250	\$841,23
2025-10-23		Guía de Nitinol hidrofílica para vías biliares/pancreatica 0,035 x 450cm longitud recta Estéril. Descartable	2	\$440,00	\$968,00	\$88,00	\$145,2000	\$1 113,20
2025-10-23		KIT-CIRCUITO DE ANESTESIA DESCARTABLE	1	\$13,00	\$14,30	\$1,30	\$2,1450	\$16,45
2025-10-23		ELECTRODOS 3M DESCARTABLE	3	\$0,28	\$0,93	\$0,08	\$0,1395	\$1,07
2025-10-23		BOLSA DE SUCCION DESCARTABLE	1	\$4,50	\$4,95	\$0,45	\$0,7425	\$5,69
2025-10-23		EQUIPO VENOCCLISIS DESCARTABLE	1	\$0,29	\$0,32	\$0,03	\$0,0480	\$0,37
2025-10-23		CATETER N°20 DESCARTABLE	1	\$0,75	\$0,83	\$0,08	\$0,1245	\$0,95
2025-10-23		MANGUERA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$2,75	\$3,03	\$0,28	\$0,4545	\$3,48
2025-10-23		JERINGAS DE 10 ML DESCARTABLE	2	\$0,11	\$0,24	\$0,02	\$0,0360	\$0,28
2025-10-23		JERINGAS DE 20 ML DESCARTABLE	2	\$0,18	\$0,40	\$0,04	\$0,0600	\$0,46
2025-10-23		Bite Block Adulto DESCARTABLE	1	\$8,00	\$8,80	\$0,80	\$1,3200	\$10,12
2025-10-23		SONDA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$0,90	\$0,99	\$0,09	\$0,1485	\$1,14
2025-10-23		BATA PACIENTE DESCARTABLE	1	\$1,20	\$1,32	\$0,12	\$0,1980	\$1,52
2025-10-23		BATA QUIRURGICA M DESCARTABLE	3	\$1,30	\$4,29	\$0,39	\$0,6435	\$4,93
2025-10-23		GORRO QUIRURGICOS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-23		MASCARILLA QUIRURGICAS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-23		ZAPATONES DESCARTABLE	8	\$0,20	\$1,76	\$0,16	\$0,2640	\$2,02
2025-10-23		GUANTES MANEJO M-S DESCARTABLE	6	\$0,07	\$0,48	\$0,04	\$0,0720	\$0,55
2025-10-23		TEGADERM APOSITO DE FIJACION DESCARTABLE	1	\$0,70	\$0,77	\$0,07	\$0,1155	\$0,89
2025-10-23		LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENCION DESCARTABLE	1	\$0,30	\$0,33	\$0,03	\$0,0495	\$0,38
2025-10-23		TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0MM DESCARTABLE	1	\$1,85	\$2,04	\$0,19	\$0,3060	\$2,35
Total			INSUMOS - VALOR AL ORIGEN					\$3 270,60
LABORATORIO								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
Total			LABORATORIO					\$0,00
IMAGEN(*)								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-23	240159	FLUROSCOPIA 30 MINUTOS	1	\$60,11	\$60,11	\$0,00	\$0,0000	\$60,11
Total			IMAGEN(*)					\$60,11
SERVICIOS INSTITUCIONALES								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-22	395162	DERECHOS DE SALA INST. SEGUNDO NIVEL	1	\$46,90	\$46,90	\$0,00	\$0,0000	\$46,90
2025-10-22	395272	SALA DE RECUPERACION. INSTITUCIONES SEGUNDO NIVEL	1	\$26,80	\$26,80	\$0,00	\$0,0000	\$26,80
2025-10-23	395162	DERECHOS DE SALA INST. SEGUNDO NIVEL	1	\$46,90	\$46,90	\$0,00	\$0,0000	\$46,90
2025-10-23	395272	SALA DE RECUPERACION. INSTITUCIONES SEGUNDO NIVEL	1	\$26,80	\$26,80	\$0,00	\$0,0000	\$26,80
Total			SERVICIOS INSTITUCIONALES					\$147,40
EQUIPOS ESPECIALES								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
Total			EQUIPOS ESPECIALES					\$0,00
			TOTAL LIQUIDACION					\$4 458,29

.....

DRA. AURA EDITH ZAMBRANO PAREDES
C.I. 0926862152
JEFE DE CONVENIOS PÚBLICOS
DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA
PRESTADOR EXTERNO

SERVICIO GASTROENTEROLOGIA	Fecha de Elaboración:	2025-10-23
	Área-Proceso:	AUDITORIA MEDICA
INFORME TÉCNICO-MÉDICO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES A LAS AUTORIZADAS		Página: 1

DATOS GENERALES	
NOMBRES Y APELLIDOS DE PACIENTE:	LUIS RODRIGO PEÑAFIEL DIAZ
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0100160480
CÓDIGO DE VALIDACIÓN QUE AUTORIZÓ PRESTACIÓN:	CV20102025RLL0010
FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE:	2025-10-23
MÉDICO SOLICITANTE:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
ESPECIALIDAD / SUBESPECIALIDAD:	GASTROENTEROLOGO

DIAGNÓSTICOS (CIE-10):	
DIAGNÓSTICO(S) QUE JUSTIFICARON EL CÓDIGO DE VALIDACIÓN:	K805 CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS
DIGANÓSTICOS ACTUALES QUE JUSTIFICARÁN LA PRESTACIÓN ADICIONAL:	K805 CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS

CUADRO CLÍNICO DEL PACIENTE QUE JUSTIFICARÁ PRESTACIÓN ADICIONAL	
PACIENTE MASCULINO DE 79 AÑOS DE EDAD, AMBULATORIO , ANTECEDENTE DE CARDIOPATIA ISQUEMICA (2 STENTS 2018) CON SUSPENSION DE CLOPIDOGREL HACE 7 DIAS , ANTECEDENTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA EN FEBRERO 2025 , PRESENTO CUADRO DE PANCREATITIS , HACE 1 MES PRESENTO CUADRO DE DOLOR ABDOMINAL , ICTERICIA , COLURIA , PERDIDA DE PESO DE 3 KILOS APROXIMADAMENTE . IMAGENES QUE EVIDENCIAN LITO EN TERCIO DISTAL Y CONDUCTO WIRSUNG DILATADO. APP: DM2, HTA, PORTADOR DE 2 STENTS CORONARIOS APF: N OREFIERE APQX: HERNIA INGUINAL , COLECISTECTOMIA ALERGIAS: NO VALORACION CARIDOLOGICA EXTERNA : EKG: RITMO SINUSAL EJE CONSERVADO FC: 62LPM, PRESENCIA DE BLOQUEO COMPLETO AMA DERECHA MAS PRESENCIA DE ONDA QS EN CARA INFERIOR DII- AVE ESCALAS GOLDMAN: I/IV LEE: II/IV RIESGO QUIRURGICO: BAJO LABORATORIOS PRE QUIRURUGICOS OK	
Diagnostico: K805 CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	
Conclusion: -CPRE + CANULACION BILIAR POR TECNICA DE DOBLE GUIA +ESFINTERECTOMIA + RETIRO DE ESCASO BARRO BILIAR + COLOCACION DE PROTESIS PLASTICA BILIAR PARA DRENAJE + INTENSO EDEMA DE MUCOSA DUODENAL Y DE PAPILA. *NOTA: RECOMENDAMOS EN 4-8 SEMANAS UNA VEZ SUPERADO EL EVENTO PANCREATICO, NUEVA CPRE CON RETIRO DE STENT Y ECOENDOSCOPIA PANCREATICA	

PROTOCOLOS UTILIZADOS QUE JUSTIFICAN LA PRESTACIÓN ADICIONAL REALIZADA:					
NO.	PROTOCOLOS	TIPO * (SELECCIONE CON UNA X)			OBERVACIONES
		NAC	INTERN.	MBE	
1	The role of endoscopy in the management of choledocholithiasis		X		Maple JT, Fisher L, Fukami N, Hwang JH, Jain R, Jue T, et al. The role of endoscopy in the management of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc. 2011;74(4):731–44.
2	lesión gástrica posible neoplasia.		X	X	Clinical impact of confocal laser endomicroscopy in the management of gastrointestinal lesions with an uncertain diagnosis. World J Gastrointest Endosc. 2017 Aug 16;9(8):389-395. doi: 10.4253/wjge.v9.i8.389.
3	Diagnóstico y Tratamiento del Adenocarcinoma de Páncreas en el Adulto		X		Guía de Referencia Rápida Catálogo maestro de guías de práctica clínica IMSS-324-10
4	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS		X		CATALOGO MAESTRO DE GUIAS PRACTICAS CLINICA IMSS-237-09
5	The role of endoscopy in the management of choledocholithiasis		X		Maple JT, Fisher L, Fukami N, Hwang JH, Jain R, Jue T, et al. The role of endoscopy in the management of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc. 2011;74(4):731–44.
6	lesión gástrica posible neoplasia.		X	X	Clinical impact of confocal laser endomicroscopy in the management of gastrointestinal lesions with an uncertain diagnosis. World J Gastrointest Endosc. 2017 Aug 16;9(8):389-395. doi: 10.4253/wjge.v9.i8.389.
7	Diagnóstico y Tratamiento del Adenocarcinoma de Páncreas en el Adulto		X		Guía de Referencia Rápida Catálogo maestro de guías de práctica clínica IMSS-324-10
8	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS		X		CATALOGO MAESTRO DE GUIAS PRACTICAS CLINICA IMSS-237-09
*TIPO: NACIONALES (NAC), INTERNACIONALES (INTERN), BUENAS PRACTICAS MÉDICAS BASADAS EN MEDICNA BASADA EN EVIDENCIA (MBE)					

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES AL AUTORIZADO QUE SERÁN JUSTIFICADOS CON ESTE INFORME:		
NO.	COD. TARIFARIO	DESCRIPCIÓN
1	43273	CANULACION ENDOSCOPICA DE LA PAPILA, CON VISUALIZACION DIRECTA DEL CONDUCTO BILIAR O CONDUCTO PANCREATICO (LISTAR POR SEPARADO AL PROCEDIMIENTO PRIMARIO)
2	43264	COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (ERCP), CON REMOCION ENDOSCOPICA RETROGRADA DE CALCULOS DEL CONDUCTO BILIAR Y/O PANCREATICO.
3	43268	COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (ERCP), CON INSERCIÓN ENDOSCOPICA RETROGRADA DE TUBO O STENT EN EL CONDUCTO BILIAR O PANCREATICO.
4	43262	COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (ERCP), PARA ESFINTERECTOMIA / PAPILOTOMIA.

Nota: Este informe no justifica la prescripción de medicamentos fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos sin la autorización debida según la normativa legal vigente para el caso, Homologaciones de procedimientos y/o laboratorios no autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, facturación indebida de acuerdo al Tarifario de Prestaciones de Salud pertinente y otras situaciones de igual similitud.

	NOMBRE	CARGO/ESPECIALIDAD	FIRMA Y SELLO
--	--------	--------------------	---------------

Elaborado por:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO	 Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140
----------------	-----------------------------------	------------------	---



Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas

Fecha: Guayaquil, 22 de Octubre del 2025

Nombre: LUIS RODRIGO PEÑAFIEL DIAZ

CI. 0100160480

Edad: 79 años

Alergia: NO

Rp:

Dra. Del Valle Zavala Raquel Salome

GASTROENTEROLOGA

C.I. 0916461221



Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas

Fecha: Guayaquil, 22 de Octubre del 2025

Nombre: LUIS RODRIGO PEÑAFIEL DIAZ

CI. 0100160480

Edad: 79 años

Alergia: NO

Prescripción:

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE									
INSTITUCION DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA			NÚMERO DE ARCHIVO			
IESS	26699	DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	0100160480						
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
						H	D	M	A
PEÑAFIEL	DIAZ	LUIS	RODRIGO	Masculino	79				x

B. DIAGNÓSTICOS			CIE
Post Operatorio:	1	CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	K805

C. PROCEDIMIENTO		Electiva	X	Emergencia		Urgencia	
Proyectado:	CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS						
Realizado:	CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS						

D. INTEGRANTES DEL EQUIPO QUIRÚRGICO			
Cirujano 1:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	Instrumentista:	
Cirujano 2:		Circulante:	
Primer Ayudante:	Dr(a). ALCIVAR VASQUEZ JUAN MANUEL	Anestesiologo/a:	Dr(a). ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA
Segundo Ayudante:		Ayudante Anestesia:	
Tercer Ayudante:		Otros:	

E. TIPO ANESTESIA	General	X	Regional		Sedación		Otros	
-------------------	---------	---	----------	--	----------	--	-------	--

F. TIEMPOS QUIRÚRGICOS					
FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACION
	23	10	2025	10:00:00	11:00:00
Dieresis:					
Exposición y Exploración:					
Hallazgos Quirúrgicos:	-CPRE + CANULACION BILIAR POR TECNICA DE DOBLE GUIA +ESFINTERECTOMIA + RETIRO DE ESCASO BARRO BILIAR + COLOCACION DE PROTESIS PLASTICA BILIAR PARA DRENAJE + INTENSO EDEMA DE MUCOSA DUODENAL Y DE PAPILA. *NOTA: RECOMENDAMOS EN 4-8 SEMANAS UNA VEZ SUPERADO EL EVENTO PANCREATICO, NUEVA CPRE CON RETIRO DE STENT Y ECOENDOSCOPIA PANCREATICA				
Procedimiento Quirúrgico:	BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEOCOLEDOSCOPIO ACOPLADO AL CAP REVEAL 12,4 MM DESCARTABLE A TRAVES DE BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLEPOR VIA ORAL HASTA D2, LA MUCOSA ESTA INTENSAMENTE EDEMATOSA Y FRIABLE POR SU PANCREATITIS, EVIDENCIAMOS LA PAPILA TANGENCIALMENTE, CON EL USO DE UNEsfinterotomo de Canulación, triple lumen, punta cónica 5mm, alambre de corte 20mm con aislante, long 200cm Estéril. DescartableACOPLADO A Guía de Nitinol hidrofílica para vías biliares/pancreática 0,035 x 450cm longitud recta Estéril. DescartablePROCEDEMOS A CANULAR EL CONDUCTO PANCREATICO DEJANDO GUIA EN PLAZA, POSTERIORMENTE CON UNA SEGUNDAGuía de Nitinol hidrofílica para vías biliares/pancreática 0,035 x 450cm longitud recta Estéril. DescartableSE CATETERIZA SELECTIVAMENTE LA VIA BILIAR BAJO GUIA FLUOROSCOPICA(30 MINUTOS) UTILIZANDO INTENSIFICADOR DE IMÁGENES. A LA INYECCION CON CONTRASTE(PAMIRAY 300 AMP X 100 ML) IDENTIFICAMOS LA PRESENCIA DE ESCASO BARRO BILIAR EN EL INTERIOR DEL COLEDOCO. LUEGO CON ELESFINTEROTOMO DE CANULACIÓN, TRIPLE LUMEN, PUNTA CÓNICA 5MM, ALAMBRE DE CORTE 20MM CON AISLANTE, LONG 200CM ESTÉRIL. DESCARTABLEACOPLADO AL SET DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ENDOCORTE DESCARTABLE PROCEDEMOS A REALIZAR UNA ESFINTERECTOMIA SELECTIVA. A CONTINUACION CON EL BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES, TRIPLE LUMEN, 12-15-18, INYECCIÓN DISTAL, DIAM CATÉTER 7FR LONG 200CM, CANAL DE TRABAJO 2.8 ESTÉRIL. DESCARTABLE RETIRAMOS BARRO BILIAR. FINALMENTE, CON EL CATETER RIEL RADIOPACO ACOPLADO ALEMPUJADOR 10 FR, LONG CATÉTER 2200 MM, CANAL DE TRABAJO 2.8 ESTÉRIL. DESCARTABLEPROCEDEMOS A COLOCAR UN STENT BILIAR PLÁSTICO 10FR X 12CM AMSTERDAM TYPE ESTÉRIL. DESCARTABLEPARA DRENAJE. CONCLUIMOS.				

G. COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

NO

Pérdida Sanguínea total:

ml

Muestra:

Descripción:

H. EXÁMENES HISTOPATOLÓGICOS

Transquirúrgico:

Biopsia por congelación:

SI

NO

Resultado:

Patólogo que reporta:

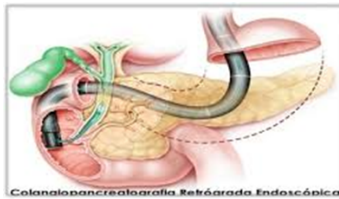
Histopatológico:

SI

x

NO

Muestra :

I. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO**J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE**

NOMBRE Y APELLIDOS	ESPECIALIDAD	FIRMA	SELLO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO		Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE

INSTITUCION DEL SISTEMA				ESTABLECIMIENTO DE SALUD				NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA				NÚMERO DE ARCHIVO					
IESS				DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA				0100160480									
PRIMER APELLIDO				SEGUNDO APELLIDO		PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE		SEXO		EDAD		CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
														H	D	M	A
PEÑAFIEL				DIAZ		LUIS		RODRIGO		Masculino		79					x
FECHA	2025-10-23			TALLA	0	PESO KG	0	IMC		GRUPO Y FACTOR			CONSENTIMIENTO INFORMADO		SI		NO

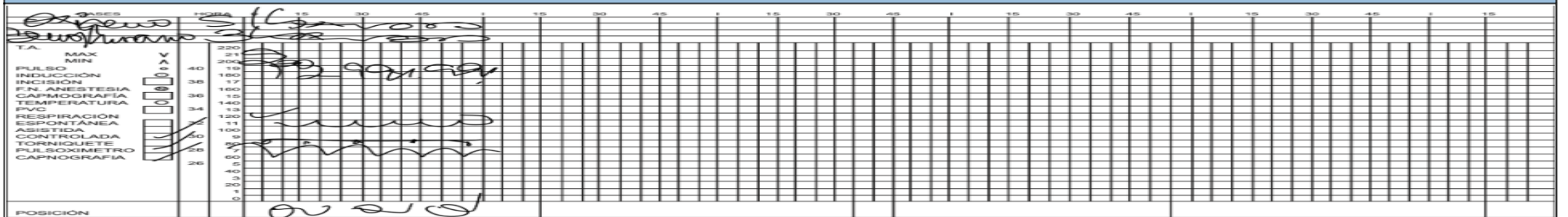
B. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO			CIE		CIRUGÍA PROPUESTA	CPRE	ESPECIALIDAD	PRIORIDAD	EMERGENTE		
DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO		CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	CIE	K805	CIRUGÍA REALIZADA	CPRE	GASTROENTEROLOGO		URGENTE		
ANESTESIÓLOGO	ANGELICA MARIA ARRIETA BRICEÑO		AYUDANTE (S)	VERENA ELIZABETH TANDAZO VALAREZO	INSTRUMENTISTA	MILENA ASTRID RIERA HOLGUIN			QUIRÓFANO	ELECTIVO	X
CIRUJANO	CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		AYUDANTE (S)	JUAN MANUEL ALCIVAR VASQUEZ	CIRCULANTE						

C. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

CABEZA		ÓRGANOS		CUELLO		COLUMNA		TÓRAX		ABDÓMEN	X	PELVIS		EXT.SUPERIORES		EXT.INFERIORES		PERINEAL	
--------	--	---------	--	--------	--	---------	--	-------	--	---------	---	--------	--	----------------	--	----------------	--	----------	--

D. REGISTRO TRANSANESTÉSICO



E. DROGAS ADMINISTRADAS

1	PROPOFOL 200MG/20ML (600MG)	2	BROMURO DE ROCURONIO 10MG/ML (10MG)	3	LIDOCAINA S/E 2% (20MG)	4	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML (20MG)
5	ONDANSETRON 8MG/4ML (8MG)	6	FENTANILO 0.05MG/10ML (150MCG)	7	DEXAMETASONA LÍQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (8MG)	8	CEFTRIAXONA: 1G
9	ATROPINA 1MG/ML - NEOSTIGMINA 0.5MG/ML (2MG)	10	KETOROLACO 30MG/ML (60MG)	11	OMEPRAZOL 40MG	12	
13		14		15		16	

F. TÉCNICA ANESTÉSICA

GENERAL														REGIONAL										SEDO - ANALGESIA																																																							
SISTEMA						APARATO								ASEPSIA CON					HABÓN CON																																																												
ABIERTO		CERRADO		X		SEMICERRADO				CIRCUITO CIRCULAR				UNIDIRECCIONAL				LOCAL ASISTIDA					INTRAVENOSA																																																								
MANEJO DE VÍA AÉREA														TRONCULAR																																																																	
MASCARA FACIAL										SUPRAGLOTICA								TRAQUEOTOMO		BLOQUEO DE NERVIOS					NÚMERO DE INTENTOS																																																						
INTUBACIÓN														BLOQUEO DE PLEXO										NÚMERO DE INTENTOS																																																							
NASAL		X				ORAL		X		SUBMENTONEANA								VISION DIRECTA						A CIEGAS		ANESTÉSICO LOCAL					COADYUVANTE																																																
TIPO DE TUBO														TIPO DE AGUJA					EQUIPO																																																												
CONVENCIONAL		X		PREFORMADO ORAL								PREFORMADO NASAL								REFORZADO				NEUROAXIAL																																																							
DOBLE LUMEN				DIÁMETRO		7		BALÓN		SI				X		NO				TAPONAMIENTO		SI				NO		RAQUIDEA				EPIDURAL						CAUDAL				CATETER																																					
EQUIPO DE INTUBACION														TIPO DE AGUJA						NUMERO DE AGUJA						Nº DE INTENTOS						MEDIAL				LATERAL		SITIO DE PUNCIÓN																																									
CORMACK				I		X		II		X		III				IV						NUMERO INTENTOS		1		BORBOTAJE		SI				NO				ACCESO																																											
INDUCCION						MANTENIMIENTO																																																																									
INHALATORIA		X		INTRAVENOSA				X		INHALATORIA								INTRAVENOSA				BALANCEADA				X		DERMATOMA						POSICIÓN										1				2				3				4				5				6															

G. ACCESOS VASCULARES

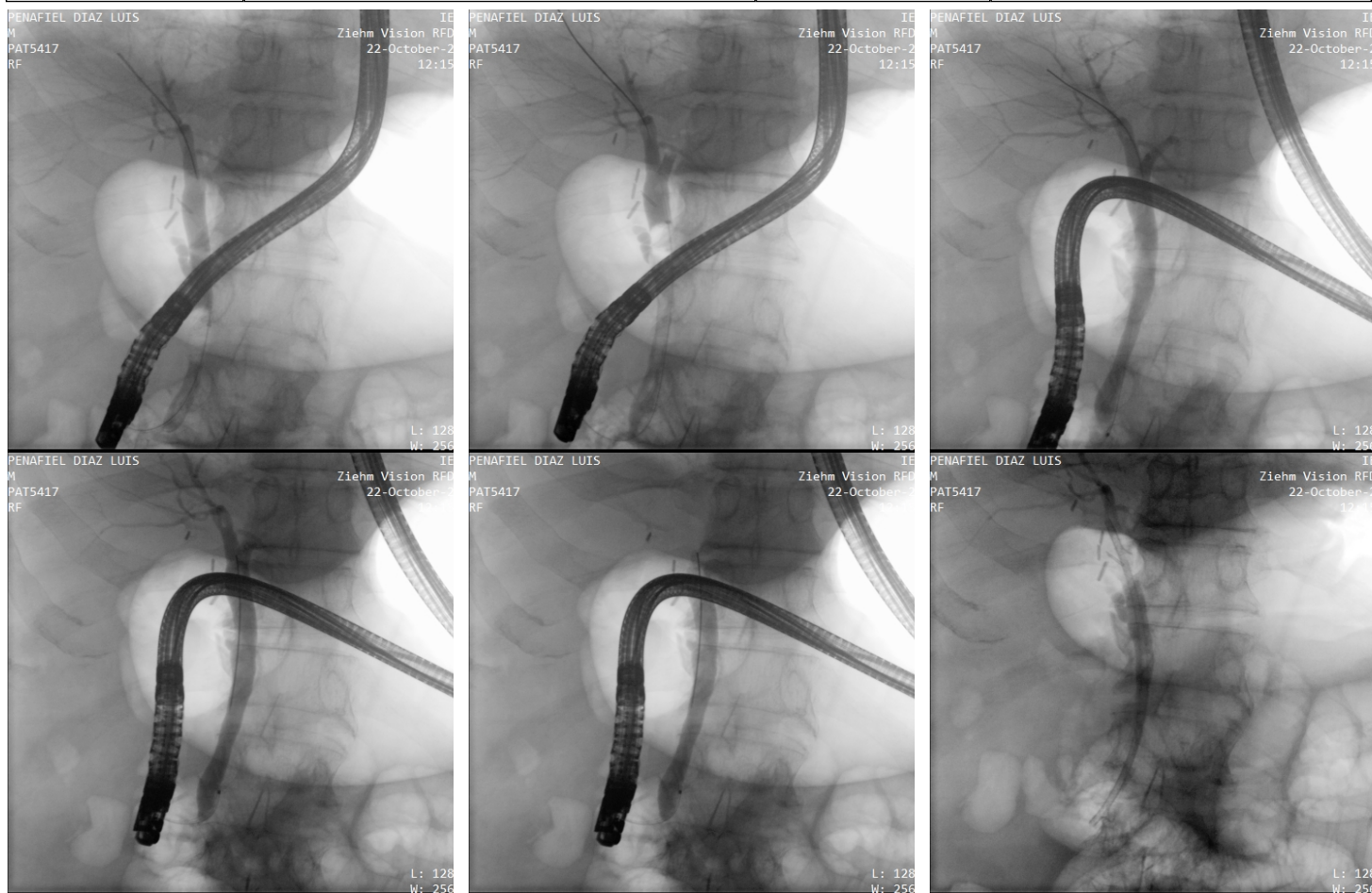
TIPO	CALIBRE	SITIO	DEXTROSA 5%		SANGRE		SANGRADO
IV PERIFÉRICO 1	20	Miembro superior izquierdo	DEXTROSA 10%		PLASMA		DIURESIS
IV PERIFÉRICO 2			DEXTROSA 50%		PLAQUETAS		OTROS
IV PERIFÉRICO 3			DEXTROSA EN SS		CRIOPRECIPITADOS		TOTAL
IV CENTRAL			SS 0.9%		OTROS		
INTRA ARTERIAL			LACTO RINGER	1000			
OTRO			EXPANSORES		TOTAL	800	BALANCE

J. DATOS DEL RECIENTE NACIDO

APGAR	FETO MUERTO	1 MINUTO	5 MINUTOS	10 MINUTOS	DURACION ANESTESIA	01:00:00	DURACION CIRUGIA	01:00:00
-------	-------------	----------	-----------	------------	--------------------	----------	------------------	----------

L. TECNICAS ESPECIALES																			
HEMODILUCIÓN				AUTOTRANSFUSIÓN				HIPOTENSIÓN				HIPOTERMIA				CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA			
M. MANTENIMIENTO TEMPERATURA CORPORAL																			
MANTA TERMICA				CALENTAMIENTO DE FLUIDOS				OTROS											
N. INCIDENTES																			
ACTIVIDAD ELÉCTRICA SIN PULSO					ARRITMIA					ASISTOLIA					TRMBOEMBOLIA				
HIPERTERMIA MALIGNA					ANAFILAXIA					ISQUEMIA MIOCÁRDICA					NEUMOTÓRAX				
BRONCOESPASMO					DESPERTAR PROLONGADO					EMBOLIA AÉREA VENOSA					LARINGOESPASMO				
DIFICULTAD DE LA TÉCNICA					OTROS														
O. RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO																			
HORA	pH	PO2	PCO2	HCO3	EB	SAT. O2	LACTATO	GLUCOSA	Na	K	Cl	HCTO	HB	OTRO					
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
P. OBSERVACIONES																			
PACIENTE PASA A SALA DE RECUPERACIÓN EN CONDICIONES ESTABLES																			
Q. CONDICIONES DE EGRESO																			
CONDICIONES AL SALIR		EXTUBADO		CONDUCTIDO A	UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTÉSICO	X	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		CRÍTICOS DE EMERGENCIA		MORGUE								
		INTUBADO																	
CONSTANTES VITALES DE ENTREGA		TA	108/70mmhg	FC	75	FR	14	SAT.O2		99	T°								
R. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE																			
HORA	11:00:00	NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL	ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA			FIRMA			SELLO Y CÓDIGO	Dra. ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA ANESTESIOLOGIA Cedula No. 1759345422									

Paciente:	PEÑAFIEL DIAZ LUIS RODRIGO	Edad:	79 años	Identificacion:	0100160480
Procedimiento:	CPRE				
Referido por:		Fecha:	22/10/2025		



Hallazgos

BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEOCOLEDOSCOPIO POR VIA ORAL HASTA D2, LA MUCOSA ESTA INTENSAMENTE EDEMATOSA Y FRIABLE POR SU PANCREATITIS, EVIDENCIAMOS LA PAPILA TANGENCIALMENTE, CON EL USO DE UN **ESFINTEROTOMO DESCARTABLE** ACOPLADO AL **HILO GUIA METALICO DESCARTABLE** PROCEDEMOS A CATETERIZAR SELECTIVAMENTE LA VIA BILIAR BAJO GUIA FLUOROSCOPICA UTILIZANDO INTENSIFICADOR DE IMÁGENES. A LA INYECCION DE CONTRASTE (**OPTIRAY 100 ML**) IDENTIFICAMOS LA PRESENCIA DE ESCASO BARRO BILIAR EN EL INTERIOR DEL COLEDOCO. CON EL **ESFINTEROTOMO DESCARTABLE** ACOPLADO AL **SET DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ENDOCORTE DESCARTABLE** PROCEDEMOS A REALIZAR UNA ESFINTERECTOMIA SELECTIVA. CON EL **CATETER BALON EXTRACTOR DESCARTABLE (Sonda Balon Descartable Limpieza de Via Biliar)** RETIRAMOS BARRO BILIAR. FINALMENTE, CON EL CATETER RIEL RADIOPACO ACOPLADO AL CATETER EMPUJADOR PROCEDEMOS A COLOCAR UN STENT PLASTICO DE 10FRX12CM PARA DRENAJE. CONCLUIMOS

Conclusiones

CPRE + ESFINTERECTOMIA + RETIRO DE ESCASO BARRO BILIAR + COLOCACION DE PROTESIS PLASTICA BILIAR PARA DRENAJE + INTENSO EDEMA DE MUCOSA DUODENAL Y DE PAPILA.

NOTA: RECOMENDAMOS EN 4-8 SEMANAS UNA VEZ SUPERADO EL EVENTO PANCREATICO, NUEVA CPRE CON RETIRO DE STENT Y ECOENDOSCOPIA PANCREATICA

Dr. Carlos Antonio Robles Medranda
GASTROENTEROLOGO
C.I 1307189140

CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO USUARIO / PACIENTE

INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NUMERO DE HISTORIA CLINICA	NUMERO DE ARCHIVO		No.HOJA		
IESS	26699	DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		0100160480					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
						H	D	M	A
PEÑAFIEL	DIAZ	LUIS	RODRIGO	Masculino	79				x

B. EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES

FIRMAR AL PIE DE CADA EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN

REGISTRAR CON ROJO LA ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

1. EVOLUCIÓN			2. PRESCRIPCIONES	
FECHA (aaaa- mm - dd)	HORA (hh:mm)	NOTAS DE EVOLUCIÓN	FARMACOTERAPIA E INDICACIONES(Para enfermería y otro profesional de salud)	ADMINISTR. FARMACOS DISPOSITIVOS
23/10/2025	08:00	PACIENTE MASCULINO DE 79 AÑOS DE EDAD, AMBULATORIO , ANTECEDENTE DE CARDIOPATIA ISQUEMICA (2 STENTS 2018) CON SUSPENSIÓN DE CLOPIDOGREL HACE 7 DIAS , ANTECEDENTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA EN FEBRERO 2025 , PRESENTO CUADRO DE PANCREATITIS , HACE 1 MES PRESENTO CUADRO DE DOLOR ABDOMINAL , ICTERICIA , COLURIA , PERDIDA DE PESO DE 3 KILOS APROXIMADAMENTE . IMAGENES QUE EVIDENCIAN LITO EN TERCIO DISTAL Y CONDUCTO WIRSUNG DILATADO. APP: DM2, HTA, PORTADOR DE 2 STENTS CORONARIOS APF: N OREFIERE APQX: HERNIA INGUINAL , COLECISTECTOMIA ALERGIAS: NO VALORACION CARDIOLOGICA EXTERNA : EKG: RITMO SINUSAL EJE CONSERVADO FC: 62LPM, PRESENCIA DE BLOQUEO COMPLETO AMA DERECHA MAS PRESENCIA DE ONDA QS EN CARA INFERIOR DII- AVE ESCALAS GOLDMAN: I/IV LEE: II/IV RIESGO QUIRURGICO: BAJO LABORATORIOS PRE QUIRURGICOS OK	1.- CSV 2.- PREPARAR PARA PROCEDIMIENTO 3.- SOL SAL 0,9% 1000cc a 30gts x min 4.-SEGUIR INDICACIONES DE MEDICO RESIDENTE 5.-SE SOLICITA EXAMENES PRE-QUIRURGICOS	
23/10/2025	11:00	PASE A SALA DE RECUPERACION DESPUES DE PROCEDIMIENTO CON SIGNOS VITALES ESTABLES.	1.- BUTIL BROMURO DE HIOSCINBA IV PRN 2.- SEGUIR INDICACIONES	
23/10/2025	12:00	PACIENTE EGRESA DE QUIROFANO ESTABLE HEMODINAMICAMENTE LUEGO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS ENDOSCOPICOS. PCTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DESPUES DEL PROCEDIMIENTO. SE MANTIENE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE. CLINICAMENTE BIEN. ES DADA DE ALTA, SE EXPLICAN LOS RESULTADOS AL PACIENTE Y ACOMPAÑANTE. SE ENTREGAN INDICACIONES AL ALTA.		



Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
GASTROENTEROLOGO
cedula No. 1307189140

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE									
INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICÓDIGO		ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA		NÚMERO DE ARCHIVO		No. HOJA
IESS	26699		DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		0100160480				
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
						D	H	M	A
PEÑAFIEL	DIAZ	LUIS	RODRIGO	MASCULINO	79				X

B. RESUMEN DE CUADRO CLINICO									
PACIENTE MASCULINO DE 79 AÑOS DE EDAD, AMBULATORIO , ANTECEDENTE DE CARDIOPATIA ISQUEMICA (2 STENTS 2018) CON SUSPENSION DE CLOPIDOGREL HACE 7 DIAS , ANTECEDENTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA EN FEBRERO 2025 , PRESENTO CUADRO DE PANCREATITIS , HACE 1 MES PRESENTO CUADRO DE DOLOR ABDOMINAL , ICTERICIA , COLURIA , PERDIDA DE PESO DE 3 KILOS APROXIMADAMENTE . IMAGENES QUE EVIDENCIAN LITO EN TERCIO DISTAL Y CONDUCTO WIRSUNG DILATADO. APP: DM2, HTA, PORTADOR DE 2 STENTS CORONARIOS APF: N OREFIERE APQX: HERNIA INGUINAL , COLECISTECTOMIA ALERGIAS: NO VALORACION CARIDOLOGICA EXTERNA : EKG: RITMO SINUSAL EJE CONSERVADO FC: 62LPM, PRESENCIA DE BLOQUEO COMPLETO AMA DERECHA MAS PRESENCIA DE ONDA QS EN CARA INFERIOR DII- AVE ESCALAS GOLDMAN: I/IV LEE: II/IV RIESGO QUIRURGICO: BAJO LABORATORIOS PRE QUIRURGICOS OK PACIENTE EGRESA DE QUIROFANO ESTABLE HEMODINAMICAMENTE LUEGO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS ENDOSCOPICOS. PCTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DESPUES DEL PROCEDIMIENTO. SE MANTIENE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE. CLINICAMENTE BIEN. ES DADA DE ALTA, SE EXPLICAN LOS RESULTADOS AL PACIENTE Y ACOMPAÑANTE. SE ENTREGAN INDICACIONES AL ALTA.									

C. RESUMEN DE EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES	
Evolución	Complicación
FAVORABLE	NINGUNA

D. HALLAZGOS RELEVANTES DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS									
-CPRE + CANULACION BILIAR POR TECNICA DE DOBLE GUIA + ESFINTERECTOMIA + RETIRO DE ESCASO BARRO BILIAR + COLOCACION DE PROTESIS PLASTICA BILIAR PARA DRENAJE + INTENSO EDEMA DE MUCOSA DUODENAL Y DE PAPILA. *NOTA: RECOMENDAMOS EN 4-8 SEMANAS UNA VEZ SUPERADO EL EVENTO PANCREATICO, NUEVA CPRE CON RETIRO DE STENT Y ECOENDOSCOPIA PANCREATICA									

DATOS DEL USUARIO / PACIENTE				
PRIMER APELLIDO	PRIMER NOMBRE	EDAD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA	NÚMERO DE ARCHIVO
PEÑAFIEL	LUIS	79	0100160480	

E. RESUMEN DE TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS
BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEOCOLEDOSCOPIO ACOPLADO AL CAP REVEAL 12,4 MM DESCARTABLE A TRAVES DE BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLE POR VIA ORAL HASTA D2, LA MUCOSA ESTA INTENSAMENTE EDEMATOSA Y FRIABLE POR SU PANCREATITIS, EVIDENCIAMOS LA PAPILA TANGENCIALMENTE, CON EL USO DE UN Esfinterotomo de Canulación, triple lumen, punta cónica 5mm, alambre de corte 20mm con aislante, long 200cm Estéril. Descartable ACOPLADO A Guía de Nitinol hidrofílica para vías biliares/pancreática 0,035 x 450cm longitud recta Estéril. Descartable PROCEDEMOS A CANULAR EL CONDUCTO PANCREATICO DEJANDO GUIA EN PLAZA, POSTERIORMENTE CON UNA SEGUNDA Guía de Nitinol hidrofílica para vías biliares/pancreática 0,035 x 450cm longitud recta Estéril. Descartable SE CATETERIZA SELECTIVAMENTE LA VIA BILIAR BAJO GUIA FLUOROSCOPICA (30 MINUTOS) UTILIZANDO INTENSIFICADOR DE IMÁGENES. A LA INYECCION CON CONTRASTE (PAMIRAY 300 AMP X 100 ML) IDENTIFICAMOS LA PRESENCIA DE ESCASO BARRO BILIAR EN EL INTERIOR DEL COLEDOCO. LUEGO CON EL ESFINTEROTOMO DE CANULACIÓN, TRIPLE LUMEN, PUNTA CÓNICA 5MM, ALAMBRE DE CORTE 20MM CON AISLANTE, LONG 200CM ESTÉRIL. DESCARTABLE ACOPLADO AL SET DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ENDOCORTE DESCARTABLE PROCEDEMOS A REALIZAR UNA ESFINTERECTOMIA SELECTIVA. A CONTINUACION CON EL BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES, TRIPLE LUMEN, 12-15-18, INYECCIÓN DISTAL, DIAM CATÉTER 7FR LONG 200CM, CANAL DE TRABAJO 2.8 ESTÉRIL. DESCARTABLE RETIRAMOS BARRO BILIAR. FINALMENTE, CON EL CATETER RIEL RADIOPACO ACOPLADO AL EMPUJADOR 10 FR, LONG CATÉTER 2200 MM, CANAL DE TRABAJO 2.8 ESTÉRIL. DESCARTABLE PROCEDEMOS A COLOCAR UN STENT BILIAR PLÁSTICO 10FR X 12CM AMSTERDAM TYPE ESTÉRIL. DESCARTABLE PARA DRENAJE. CONCLUIMOS.

F. INDICACIONES DE ALTA / EGRESO
PRÓXIMO CONTROL

G. DIAGNOSTICO DE ALTA / EGRESO		CIE
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL	CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	K805
CAUSA EXTERNA		

H. CONDICIÓN DE ALTA / EGRESO					VIVO	FALLECIDO
ALTA MÉDICA	X	DISCAPACIDAD		RETIRO NO AUTORIZADO	DEFUNCIÓN MENOS DE 48 HORAS	DÍAS DE ESTADIA
ALTA VOLUNTARIA				AUTORIZADO	DEFUNCIÓN MAS DE 48 HORAS	DÍAS DE REPOSO

I. MÉDICOS TRATANTES			
NOMBRE Y APELLIDOS		ESPECIALIDAD	SELLO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL
1.	Dr. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	GASTROENTEROLOGO	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140

J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE				
FECHA	HORA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
2025-10-23		Dr. CARLOS	ROBLES	MEDRANDA
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		FIRMA		SELLO
1307189140				Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140
ELABORADO POR:		Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO		REVISADO POR: Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO

SERVICIO GASTROENTEROLOGIA	Fecha de Elaboración:	2025-10-22
	Área-Proceso:	AUDITORIA MEDICA
INFORME TÉCNICO-MÉDICO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES A LAS AUTORIZADAS		Página: 1

DATOS GENERALES	
NOMBRES Y APELLIDOS DE PACIENTE:	LUIS RODRIGO PEÑAFIEL DIAZ
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0100160480
CÓDIGO DE VALIDACIÓN QUE AUTORIZÓ PRESTACIÓN:	CV20102025RLL0010
FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE:	2025-10-22
MÉDICO SOLICITANTE:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
ESPECIALIDAD / SUBESPECIALIDAD:	GASTROENTEROLOGO

DIAGNÓSTICOS (CIE-10):	
DIAGNÓSTICO(S) QUE JUSTIFICARON EL CÓDIGO DE VALIDACIÓN:	K85 PANCREATITIS AGUDA
DIGANÓSTICOS ACTUALES QUE JUSTIFICARÁN LA PRESTACIÓN ADICIONAL:	K805 CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS

CUADRO CLÍNICO DEL PACIENTE QUE JUSTIFICARÁ PRESTACIÓN ADICIONAL	
PACIENTE MASCULINO DE 79 AÑOS DE EDAD, AMBULATORIO , ANTECEDENTE DE CARDIOPATIA ISQUEMICA (2 STENTS 2018) CON SUSPENSIÓN DE CLOPIDOGREL HACE 7 DÍAS , ANTECEDENTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA EN FEBRERO 2025 , PRESENTO CUADRO DE PANCREATITIS , HACE 1 MES PRESENTO CUADRO DE DOLOR ABDOMINAL , ICTERICIA , COLURIA , PERDIDA DE PESO DE 3 KILOS APROXIMADAMENTE . IMAGENES QUE EVIDENCIAN LITO EN TERCIO DISTAL Y CONDUCTO WIRSUNG DILATADO. APP: DM2, HTA, PORTADOR DE 2 STENTS CORONARIOS APP: N OREFIERE APQX: HERNIA INGUINAL , COLECISTECTOMIA ALERGIAS: NO VALORACION CARDIOLOGICA EXTERNA : EKG: RITMO SINUSAL EJE CONSERVADO FC: 62LPM, PRESENCIA DE BLOQUEO COMPLETO AMA DERECHA MAS PRESENCIA DE ONDA QS EN CARA INFERIOR DII- AVE ESCALAS GOLDMAN: I/IV LEE: II/IV RIESGO QUIRURGICO: BAJO LABORATORIOS PRE QUIRURGICOS OK Diagnostico: K805 CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS Conclusion: -PANCREATITIS AGUDA EN RESOLUCION -BARRO BILIAR -ESTEATOSIS HEPATICA -ESTEATOSIS PANCREATICA	

PROTOCOLOS UTILIZADOS QUE JUSTIFICAN LA PRESTACIÓN ADICIONAL REALIZADA:					
NO.	PROTOCOLOS	TIPO * (SELECCIONE CON UNA X)			OBSERVACIONES
		NAC	INTERN.	MBE	
1	ecoendoscopia en coledocolitiasis		X	X	Diagnostic accuracy of EUS compared with MRCP in detecting choledocholithiasis: a meta-analysis of diagnostic test accuracy in head-to-head studies. Gastrointest Endosc. 2017 Dec;86(6):986-993. doi: 10.1016/j.gie.2017.06.009. Epub 2017 Jun 20.
2	ecoendoscopia en coledocolitiasis		X	X	Diagnostic accuracy of EUS compared with MRCP in detecting choledocholithiasis: a meta-analysis of diagnostic test accuracy in head-to-head studies. Gastrointest Endosc. 2017 Dec;86(6):986-993. doi: 10.1016/j.gie.2017.06.009. Epub 2017 Jun 20.
*TIPO: NACIONALES (NAC), INTERNACIONALES (INTERN), BUENAS PRACTICAS MÉDICAS BASADAS EN MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA (MBE)					

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES AL AUTORIZADO QUE SERÁN JUSTIFICADOS CON ESTE INFORME:		
NO.	COD. TARIFARIO	DESCRIPCIÓN
1	43259	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON ECOENDOSCOPIA, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SI ES APROPIADO.

Nota: Este informe no justifica la prescripción de medicamentos fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos sin la autorización debida según la normativa legal vigente para el caso, Homologaciones de procedimientos y/o laboratorios no autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, facturación indebida de acuerdo al Tarifario de Prestaciones de Salud pertinente y otras situaciones de igual similitud.

	NOMBRE	CARGO/ESPECIALIDAD	FIRMA Y SELLO
Elaborado por:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO	 Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140



Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas

Fecha: Guayaquil, 22 de Octubre del 2025

Nombre: LUIS RODRIGO PEÑAFIEL DIAZ

CI. 0100160480

Edad: 79 años

Alergia: NO

Rp:

Dra. Del Valle Zavala Raquel Salome

GASTROENTEROLOGA

C.I. 0916461221



Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas

Fecha: Guayaquil, 22 de Octubre del 2025

Nombre: LUIS RODRIGO PEÑAFIEL DIAZ

CI. 0100160480

Edad: 79 años

Alergia: NO

Prescripción:

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE									
INSTITUCION DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA	NÚMERO DE ARCHIVO					
IESS	26699	DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	0100160480						
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
						H	D	M	A
PEÑAFIEL	DIAZ	LUIS	RODRIGO	Masculino	79				x

B. DIAGNÓSTICOS			CIE
Post Operatorio:	1	CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	K805

C. PROCEDIMIENTO		Electiva	X	Emergencia		Urgencia	
Proyectado:	PANCREATITIS AGUDA						
Realizado:	PANCREATITIS AGUDA						

D. INTEGRANTES DEL EQUIPO QUIRÚRGICO			
Cirujano 1:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	Instrumentista:	
Cirujano 2:		Circulante:	
Primer Ayudante:	Dr(a). ALCIVAR VASQUEZ JUAN MANUEL	Anestesiologo/a:	Dr(a). ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA
Segundo Ayudante:		Ayudante Anestesia:	
Tercer Ayudante:		Otros:	

E. TIPO ANESTESIA	General	X	Regional		Sedación		Otros	

F. TIEMPOS QUIRÚRGICOS					
FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACION
		22	10	2025	10:00:00
Dieresis:					
Exposición y Exploración:					
Hallazgos Quirúrgicos:					
-PANCREATITIS AGUDA EN RESOLUCION -BARRO BILIAR -ESTEATOSIS HEPATICA -ESTEATOSIS PANCREATICA					
Procedimiento Quirúrgico:					
BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEO ECOENDOSCOPIO RADIAL ELECTRONICO ACOPLADO AL CAP REVEAL 12,4 MM DESCARTABLE A TRAVES DE BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLE CON EL USO DE LOS ENDOKITS (KIT INTRODUCTOR DE ECOENDOSCOPIA RADIAL) ACOPLADO AL BALON ECOENDOSCOPIO DESCARTABLE. CON AYUDA DEL SET DESCARTABLE PARA PROCESADOR DE ULTRASONIDO MÁS EL SET DE PROCESADOR DE ECOENDOSCOPIA Y SE OBSERVA: MEDIASTINO NORMAL. EN LA VENTANA GASTRICA LAS ESTRUCTURAS: HIGADO CON ECOESTRUCTURA HIPERECOGENICO, BAZO, RIÑON Y VASOS NO MUESTRAN ALTERACIONES. CUERPO DE PANCREAS PRESENTA ASPECTO HIPERECOGENICO CON STRAIN RATIO 3.7 Y STRAIN HISTOGRAM 60-80. SE OBSERVA EDEMA DE LA GRASA PERIPANCREATICA. NO SE OBSERVAN COLECCIONES AGUDAS. EN LA VENTANA DUODENAL LA CABEZA DE PANCREAS DE ASPECTO HIPERECOGENICO. COLEDOCO MIDE CON 8.5 MM Y CON PRESENCIA DE BARRO BILIAR EN SU INTERIOR. EN LA VESICULA BILIAR AUSENTE POR ANTECEDENTE QUIRURGICO.					

G. COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

NO

Pérdida Sanguínea total:

 ml Muestra:

Descripción:

H. EXÁMENES HISTOPATOLÓGICOS

Transquirúrgico:

Biopsia por congelación:

 SI NO Resultado:

Patólogo que reporta:

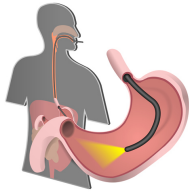
Histopatológico:

 SI

x

 NO Muestra :

I. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO



J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS	ESPECIALIDAD	FIRMA	SELLO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO		Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE

INSTITUCION DEL SISTEMA				ESTABLECIMIENTO DE SALUD				NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA				NÚMERO DE ARCHIVO					
IESS				DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA				0100160480									
PRIMER APELLIDO				SEGUNDO APELLIDO		PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE		SEXO	EDAD		CONDICIÓN EDAD (MARCAR)				
PEÑAFIEL				DÍAZ		LUIS		RODRIGO		Masculino	79		H	D	M	A	
																x	
FECHA	2025-10-22			TALLA	0	PESO KG	0	IMC		GRUPO Y FACTOR			CONSENTIMIENTO INFORMADO		SI		NO

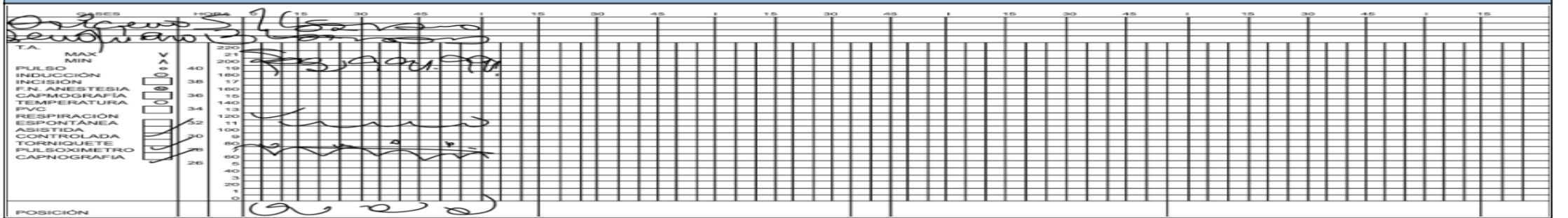
B. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO			CIE		CIRUGÍA PROPUESTA	ECOENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA	ESPECIALIDAD	PRIORIDAD	EMERGENTE	
DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO		CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	CIE	K805	CIRUGÍA REALIZADA	ECOENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA	GASTROENTEROLOGO		URGENTE	
ANESTESIÓLOGO	ANGELICA MARIA ARRIETA BRICEÑO		AYUDANTE (S)	VERENA ELIZABETH TANDAZO VALAREZO	INSTRUMENTISTA	MILENA ASTRID RIERA HOLGUIN	QUIRÓFANO		ELECTIVO	X
CIRUJANO	CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		AYUDANTE (S)	JUAN MANUEL ALCIVAR VASQUEZ	CIRCULANTE					
OTROS										

C. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

CABEZA		ÓRGANOS		CUELLO		COLUMNA		TÓRAX		ABDÓMEN		X	PELVIS		EXT.SUPERIORES		EXT.INFERIORES		PERINEAL	
--------	--	---------	--	--------	--	---------	--	-------	--	---------	--	---	--------	--	----------------	--	----------------	--	----------	--

D. REGISTRO TRANSANESTÉSICO



E. DROGAS ADMINISTRADAS

1	PROPOFOL 200MG/20ML (600MG)	2	BROMURO DE ROCURONIO 10MG/ML (10MG)	3	LIDOCAINA S/E 2% (20MG)	4	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML (20MG)
5	ONDANSETRON 8MG/4ML (8MG)	6	FENTANILO 0.05MG/10ML (150MCG)	7	DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (8MG)	8	CEFTRIAXONA: 1G
9	ATROPINA 1MG/ML - NEOSTIGMINA 0.5MG/ML (2MG)	10	KETOROLACO 30MG/ML (60MG)	11	OMEPRAZOL 40MG	12	
13		14		15		16	

F. TÉCNICA ANESTÉSICA

GENERAL																REGIONAL								SEDO - ANALGESIA																																											
SISTEMA								APARATO								ASEPSIA CON				HABÓN CON																																															
ABIERTO				CERRADO		X		SEMICERRADO				CIRCUITO CIRCULAR				UNIDIRECCIONAL				LOCAL ASISTIDA								INTRAVENOSA																																							
MANEJO DE VÍA AÉREA																TRONCULAR																																																			
MASCARA FACIAL								SUPRAGLÓTICA										TRAQUEOTOMIA				BLOQUEO DE NERVIOS								NÚMERO DE INTENTOS																																					
INTUBACIÓN																BLOQUEO DE PLEXO								NÚMERO DE INTENTOS																																											
NASAL		X				ORAL		X		SUBMENTONEANA						VISION DIRECTA								ANESTÉSICO LOCAL								COADYUVANTE																																			
TIPO DE TUBO																TIPO DE AGUJA								EQUIPO																																											
CONVENCIONAL		X				PREFORMADO ORAL								PREFORMADO NASAL								REFORZADO								NEUROAXIAL																																					
DOBLES LUMENES				DIÁMETRO		7		BALÓN		SI		X		NO		TAPONAMIENTO				SI				NO		RAQUIDEA				EPIDURAL								CAUDAL				CATETER																									
EQUIPO DE INTUBACION																TIPO DE AGUJA								NÚMERO DE AGUJA								Nº DE INTENTOS																																			
CORMACK				I		X		II		X		III				IV		NÚMERO DE INTENTOS				1		BORBOTAJE		SI						NO								ACCESO				MEDIAL				LATERAL				SITIO DE PUNCIÓN															
INDUCCIÓN								MANTENIMIENTO								DERMATOMA								POSICIÓN																																											
INHALATORIA		X		INTRAVENOSA				X		INHALATORIA								INTRAVENOSA				BALANCEADA				X																		1				2				3				4				5				6			

G. ACCESOS VASCULARES

TIPO	CALIBRE	SITIO	DEXTROSA 5%	SANGRE	SANGRADO
IV PERIFÉRICO 1	20	Miembro superior derecho	DEXTROSA 10%	PLASMA	DIURESIS
IV PERIFÉRICO 2			DEXTROSA 50%	PLAQUETAS	OTROS
IV PERIFÉRICO 3			DEXTROSA EN SS	CRIOPRECIPITADOS	
IV CENTRAL			SS 0.9%		TOTAL
INTRA ARTERIAL			LACTO RINGER	1000	OTROS
OTRO			EXPANSORES	TOTAL	800
					BALANCE

J. DATOS DEL RECIENTE NACIDO

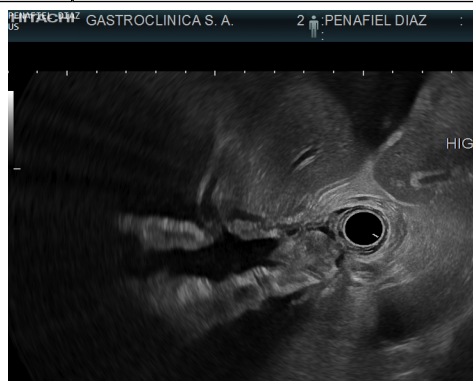
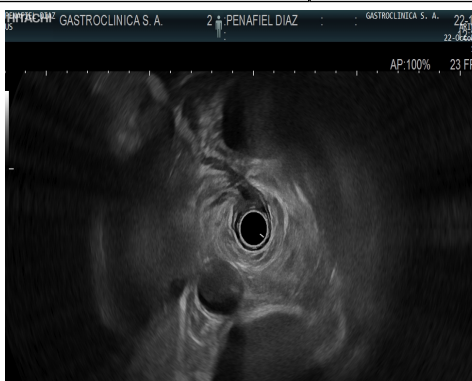
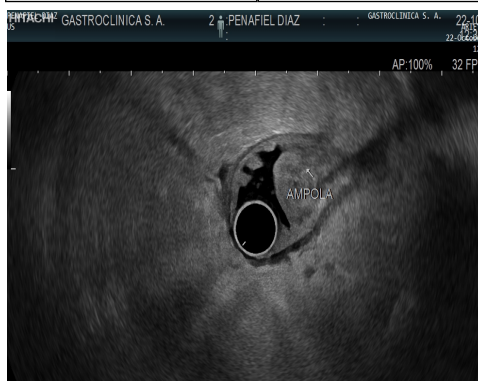
APGAR	FETO MUERTO		1 MINUTO		5 MINUTOS		10 MINUTOS		DURACION ANESTESIA	01:00:00	DURACION CIRUGIA	01:00:00
-------	-------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--	--------------------	----------	------------------	----------

K. TIEMPOS TRANSCURRIDOS

DURACION ANESTESIA	01:00:00	DURACION CIRUGIA	01:00:00
--------------------	----------	------------------	----------

L. TECNICAS ESPECIALES															
HEMODILUCIÓN			AUTOTRANSFUSIÓN			HIPOTENSIÓN			HIPOTERMIA			CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA			
M. MANTENIMIENTO TEMPERATURA CORPORAL															
MANTA TERMICA			CALENTAMIENTO DE FLUIDOS			OTROS									
N. INCIDENTES															
ACTIVIDAD ELÉCTRICA SIN PULSO			ARRITMIA			ASISTOLIA			TRMBOEMBOLIA						
HIPERTERMIA MALIGNA			ANAFILAXIA			ISQUEMIA MIOCÁRDICA			NEUMOTÓRAX						
BRONCOESPASMO			DESPERTAR PROLONGADO			EMBOLIA AÉREA VENOSA			LARINGOESPASMO						
DIFICULTAD DE LA TÉCNICA			OTROS												
O. RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO															
HORA	pH	PO2	PCO2	HCO3	EB	SAT. O2	LACTATO	GLUCOSA	Na	K	Cl	HCTO	HB	OTRO	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
P. OBSERVACIONES															
PACIENTE PASA A SALA DE RECUPERACIÓN EN CONDICIONES ESTABLES															
Q. CONDICIONES DE EGRESO															
CONDICIONES AL SALIR		EXTUBADO		CONDUCTIDO A	UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTÉSICO	X	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		CRÍTICOS DE EMERGENCIA		MORGUE				
		INTUBADO													
CONSTANTES VITALES DE ENTREGA		TA	108/70mmhg	FC	75	FR	14	SAT.O2		99	T°				
R. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE															
HORA	11:00:00	NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL	ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA			FIRMA	<i>Angelica H. Arrieta B.</i>		SELLO Y CÓDIGO	Dra. ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA ANESTESIOLOGIA Cedula No. 1759345422					

Paciente:	PEÑAFIEL DIAZ LUIS RODRIGO	Edad:	79 años	Identificacion:	0100160480
Procedimiento:	ECOENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA				
Referido por:		Fecha:	22/10/2025		



EG36J10UR
FND-7.5R R:8.00 BG:69 BD:90
EUS Radia
110
PROX

EG36J10UR
FND-7.5R R:12.0 BG:69 BD:90
EUS Radia
115
PROX

EG36J10UR
FND-7.5R R:12.0 BG:69 BD:90
EUS Radia
115
PROX



EG36J10UR
FND-7.5R R:12.0 BG:69 BD:90

EG36J10UR
FND-7.5R R:10.0 BG:69 BD:90

EG36J10UR
FND-7.5R R:8.00 BG:69 BD:90

Hallazgos

SE OBSERVA EDEMA DE LA GRASA PERIPANCREATICA. NO SE OBSERVAN COLECCIONES AGUDAS. EN LA VENTANA DUODENAL LA CABEZA DE PANCREAS

Conclusiones

- PANCREATITIS AGUDA EN RESOLUCION
- BARRO BILIAR
- ESTEATOSIS HEPATICA
- ESTEATOSIS PANCREATICA

Dr. Carlos Antonio Robles Medranda

Dr. Carlos Antonio Robles Medranda
GASTROENTEROLOGO
C.I 1307189140

CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO USUARIO / PACIENTE

INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NUMERO DE HISTORIA CLINICA	NUMERO DE ARCHIVO		No.HOJA		
IESS	26699	DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		0100160480					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
						H	D	M	A
PEÑAFIEL	DIAZ	LUIS	RODRIGO	Masculino	79				x

B. EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES

FIRMAR AL PIE DE CADA EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN

REGISTRAR CON ROJO LA ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

1. EVOLUCIÓN			2. PRESCRIPCIONES	
FECHA (aaaa- mm - dd)	HORA (hh:mm)	NOTAS DE EVOLUCIÓN	FARMACOTERAPIA E INDICACIONES(Para enfermería y otro profesional de salud)	ADMINISTR. FARMACOS DISPOSITIVOS
22/10/2025	08:00	PACIENTE MASCULINO DE 79 AÑOS DE EDAD, AMBULATORIO , ANTECEDENTE DE CARDIOPATIA ISQUEMICA (2 STENTS 2018) CON SUSPENSIÓN DE CLOPIDOGREL HACE 7 DIAS , ANTECEDENTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA EN FEBRERO 2025 , PRESENTO CUADRO DE PANCREATITIS , HACE 1 MES PRESENTO CUADRO DE DOLOR ABDOMINAL , ICTERICIA , COLURIA , PERDIDA DE PESO DE 3 KILOS APROXIMADAMENTE . IMAGENES QUE EVIDENCIAN LITO EN TERCIO DISTAL Y CONDUCTO WIRSUNG DILATADO. APP: DM2, HTA, PORTADOR DE 2 STENTS CORONARIOS APF: N OREFIERE APQX: HERNIA INGUINAL , COLECISTECTOMIA ALERGIAS: NO VALORACION CARDIOLOGICA EXTERNA : EKG: RITMO SINUSAL EJE CONSERVADO FC: 62LPM, PRESENCIA DE BLOQUEO COMPLETO AMA DERECHA MAS PRESENCIA DE ONDA QS EN CARA INFERIOR DII- AVE ESCALAS GOLDMAN: I/IV LEE: II/IV RIESGO QUIRURGICO: BAJO LABORATORIOS PRE QUIRURGICOS OK	1.- CSV 2.- PREPARAR PARA PROCEDIMIENTO 3.- SOL SAL 0,9% 1000cc a 30gts x min 4.-SEGUIR INDICACIONES DE MEDICO RESIDENTE 5.-SE SOLICITA EXAMENES PRE-QUIRURGICOS	
22/10/2025	11:00	PASE A SALA DE RECUPERACION DESPUES DE PROCEDIMIENTO CON SIGNOS VITALES ESTABLES.	1.- BUTIL BROMURO DE HIOSCINBA IV PRN 2.- SEGUIR INDICACIONES	
22/10/2025	12:00	PACIENTE EGRESA DE QUIROFANO ESTABLE HEMODINAMICAMENTE LUEGO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS ENDOSCOPICOS. PCTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DESPUES DEL PROCEDIMIENTO. SE MANTIENE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE. CLINICAMENTE BIEN. ES DADA DE ALTA, SE EXPLICAN LOS RESULTADOS AL PACIENTE Y ACOMPAÑANTE. SE ENTREGAN INDICACIONES AL ALTA.		



Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
GASTROENTEROLOGO
cedula No. 1307189140

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE									
INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICÓDIGO		ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA		NÚMERO DE ARCHIVO		No. HOJA
IESS	26699		DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		0100160480				
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
						D	H	M	A
PEÑAFIEL	DIAZ	LUIS	RODRIGO	MASCULINO	79				X

B. RESUMEN DE CUADRO CLINICO									
PACIENTE MASCULINO DE 79 AÑOS DE EDAD, AMBULATORIO , ANTECEDENTE DE CARDIOPATIA ISQUEMICA (2 STENTS 2018) CON SUSPENSION DE CLOPIDOGREL HACE 7 DIAS , ANTECEDENTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA EN FEBRERO 2025 , PRESENTO CUADRO DE PANCREATITIS , HACE 1 MES PRESENTO CUADRO DE DOLOR ABDOMINAL , ICTERICIA , COLURIA , PERDIDA DE PESO DE 3 KILOS APROXIMADAMENTE . IMAGENES QUE EVIDENCIAN LITO EN TERCIO DISTAL Y CONDUCTO WIRSUNG DILATADO. APP: DM2, HTA, PORTADOR DE 2 STENTS CORONARIOS APF: N OREFIERE APQX: HERNIA INGUINAL , COLECISTECTOMIA ALERGIAS: NO VALORACION CARIDOLOGICA EXTERNA : EKG: RITMO SINUSAL EJE CONSERVADO FC: 62LPM, PRESENCIA DE BLOQUEO COMPLETO AMA DERECHA MAS PRESENCIA DE ONDA QS EN CARA INFERIOR DII- AVE ESCALAS GOLDMAN: I/IV LEE: II/IV RIESGO QUIRURGICO: BAJO LABORATORIOS PRE QUIRURGICOS OK PACIENTE EGRESA DE QUIROFANO ESTABLE HEMODINAMICAMENTE LUEGO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS ENDOSCOPICOS. PCTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DESPUES DEL PROCEDIMIENTO. SE MANTIENE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE. CLINICAMENTE BIEN. ES DADA DE ALTA, SE EXPLICAN LOS RESULTADOS AL PACIENTE Y ACOMPAÑANTE. SE ENTREGAN INDICACIONES AL ALTA.									

C. RESUMEN DE EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES									
Evolución					Complicación				
FAVORABLE					NINGUNA				

D. HALLAZGOS RELEVANTES DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS									
-PANCREATITIS AGUDA EN RESOLUCION -BARRO BILIAR -ESTEATOSIS HEPATICA -ESTEATOSIS PANCREATICA									

DATOS DEL USUARIO / PACIENTE				
PRIMER APELLIDO	PRIMER NOMBRE	EDAD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA	NÚMERO DE ARCHIVO
PEÑAFIEL	LUIS	79	0100160480	

E. RESUMEN DE TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS
BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEO ECOENDOSCOPIO RADIAL ELECTRONICO ACOPLADO AL CAP REVEAL 12,4 MM DESCARTABLE A TRAVES DE BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLE CON EL USO DE LOS ENDOKITS (KIT INTRODUCTOR DE ECOENDOSCOPIA RADIAL) ACOPLADO AL BALON ECOENDOSCOPICO DESCARTABLE. CON AYUDA DEL SET DESCARTABLE PARA PROCESADOR DE ULTRASONIDO MAS EL SET DE PROCESADOR DE ECOENDOSCOPIA Y SE OBSERVA: MEDIASTINO NORMAL. EN LA VENTANA GASTRICA LAS ESTRUCTURAS: HIGADO CON ECOESTRUCTURA HIPERECOGENICO, BAZO, RIÑON Y VASOS NO MUESTRAN ALTERACIONES. CUERPO DE PANCREAS PRESENTA ASPECTO HIPERECOGENICO CON STRAIN RATIO 3.7 Y STRAIN HISTOGRAM 60-80. SE OBSERVA EDEMA DE LA GRASA PERIPANCREATICA. NO SE OBSERVAN COLECCIONES AGUDAS. EN LA VENTANA DUODENAL LA CABEZA DE PANCREAS DE ASPECTO HIPERCOGENICO. COLEDOCO MIDE CON 8.5 MM Y CON PRESENCIA DE BARRO BILIAR EN SU INTERIOR. EN LA VESICULA BILIAR AUSENTE POR ANTECEDENTE QUIRURGICO.

F. INDICACIONES DE ALTA / EGRESO
PRÓXIMO CONTROL

G. DIAGNOSTICO DE ALTA / EGRESO	CIE
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL	CALCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS
CAUSA EXTERNA	

H. CONDICIÓN DE ALTA / EGRESO					VIVO		FALLECIDO	
ALTA MÉDICA	X	DISCAPACIDAD		RETIRO NO AUTORIZADO	DEFUNCIÓN MENOS DE 48 HORAS		DÍAS DE ESTADIA	
ALTA VOLUNTARIA				AUTORIZADO	DEFUNCIÓN MAS DE 48 HORAS		DÍAS DE REPOSO	

I. MÉDICOS TRATANTES			
NOMBRE Y APELLIDOS		ESPECIALIDAD	SELLO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL
1.	Dr. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	GASTROENTEROLOGO	Dr. ROBLES MEDRÁND A CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140

J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE				
FECHA	HORA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
2025-10-22		Dr. CARLOS	ROBLES	MEDRANDA
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA			SELLO
1307189140				Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140
ELABORADO POR:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO		REVISADO POR:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO